Recueil et perception clinique

CM1 • UE A1 – Fondements des sciences infirmières et raisonnement clinique | Semestre 1

OBJECTIFS DU CM

Identifier des données cliniques pertinentes ; différencier **observation**, **entretien clinique** et **examen physique** ; repérer les biais et les limites du recueil.

I. Fondements de l'observation

Observer consiste à mobiliser ses sens pour **recueillir des indices**, décrire une situation et repérer une évolution. Contrairement à « regarder » ou simplement « voir », observer implique une **attention intentionnelle** et un questionnement clinique.

Regarder	Voir	Observer
Orienter son regard vers quelqu'un ou quelque chose.	Percevoir visuellement une personne, un fait.	Examiner attentivement, surveiller, décrire puis confronter les données.

À APPRENDRE PAR CŒUR

Un fait observable n'est pas une interprétation. Exemple : « Mme L. serre les mâchoires et dit avoir mal » (faits) ; « Mme L. est agressive » (jugement non démontré).

Pourquoi l'observation est-elle essentielle ?

- Elle constitue le **point de départ du raisonnement clinique** et permet de connaître la personne, ses habitudes, ses capacités, ses difficultés et son environnement.
- Elle aide à identifier une **variation de l'état de santé**, parfois avant qu'une plainte ne soit formulée.
- Une observation de qualité est **attentive, descriptive, factuelle, respectueuse** et adaptée à la personne.

ASTUCE MÉMO

Avant de conclure : « **Qu'ai-je réellement constaté ?** » puis « **Que signifie cette donnée avec les autres ?** »

Les conditions d'une bonne observation

Disponibilité (être présent), **attention et écoute**, **connaissances** pour donner du sens, **respect** de la dignité, **discrétion** et confidentialité. L'expérience aide, mais ne remplace jamais la vérification des faits.

II. Quand, comment et quoi observer ?

Observation spontanée	Observation dirigée (volontaire)
Survient à tout moment : toilette, repas, passage dans le couloir. Exemple : chute, modification inhabituelle du comportement.	Répond à une **question précise** : surveiller une douleur, une respiration, une autonomie. Utilise une grille ou des critères.

Méthode : les 4 niveaux d'environnement

Niveau	Ce que je repère	Exemple en stage
1 – Global	Situation générale de la personne, contexte de soin.	Personne seule au lit, fatiguée ou agitée.
2 – Technique	Matériel proche, appareillages, bon fonctionnement apparent.	Sonnette accessible ? Tubulure visible ?
3 – Architectural	Disposition de la chambre et risques matériels.	Sol encombré, éclairage insuffisant.
4 – Social	Proches, personne de confiance, ressources relationnelles.	Visites, besoins d'accompagnement.

Les trois sources du recueil

PATIENT
état physique/psychique

ENVIRONNEMENT
risques et ressources

DOSSIER
données déjà connues

APPLICATION EN STAGE
À l'entrée d'une chambre : identifier la personne ; vérifier l'état général et les signes de gêne ; regarder le matériel et les risques de chute ; consulter les transmissions utiles ; **demander** ce qui manque à l'observation.

Une mini-grille utilisable à la toilette

Domaine	Indices utiles à recueillir
Aspect général	Vigilance, posture, expression, couleur de la peau, respiration.
Autonomie	Capacité à se laver, se mobiliser, communiquer, demander de l'aide.
Confort / douleur	Plaintes, grimaces, posture antalgique, installation et confort.
Sécurité	Marche, aides techniques, sonnette, sol, frein du lit, dispositifs en place.
Relation / psychisme	Humeur apparente, comportement, souhaits exprimés, présence des proches.

III. Les moyens sensoriels

Le cours distingue **quatre canaux utilisés en observation infirmière** : vue, ouïe, odorat et toucher. Le goût ne s'utilise pas pour examiner le patient.

Sens	Ce que je peux constater	Exemples et vigilance
VUE	Posture, expression faciale, regard, peau, tenue, appareillages, chambre.	Pâleur, grimace, déplacement difficile, bouteille d'eau inaccessible.
OUÏE	Parole, toux, sifflements, bruits respiratoires perceptibles, alarmes.	Respiration bruyante, toux nouvelle, alarme de matériel.
ODORAT	Odeurs corporelles, urines/selles, pansement, haleine.	Odeur inhabituelle d'une plaie : un **indice**, jamais un diagnostic à elle seule.
TOUCHER	Température et texture cutanées, humidité, perception d'un œdème.	Peau chaude/moite, rougeur associée ; mains propres et accord de la personne.

VIGILANCE
Ne jamais goûter une substance corporelle. Respecter les précautions standard et le consentement ; l'examen tactile ne se fait que lorsque pertinent, expliqué et dans les compétences du professionnel.

Le matériel renseigne sur les besoins

Besoin	Exemples vus dans la chambre
Respirer / circuler	Oxygène, canule, matériel respiratoire, dispositif de surveillance.
Boire / manger	Sonde de nutrition, eau, plateau, consignes alimentaires.
Éliminer	Urinal, poche à urines, bassin, protections.
Se mouvoir / se protéger	Canne, déambulateur, plâtre, matelas, barrières selon indication.
Confort / identité	Couverture, objets personnels, livres, photos, objets de culte.

RÔLE IDE
Observer aussi la **cohérence entre matériel, prescription, sécurité et situation clinique** ; contrôler selon les protocoles applicables et alerter devant un matériel absent, débranché, inadapté ou une alarme.

IV. De l'observation à l'examen clinique

OBSERVER ce que je perçois – **QUESTIONNER** ce que la personne dit – **EXAMINER** ce que j'évalue – **RECROISER** pour comprendre

L'**examen clinique** associe l'**entretien clinique** (histoire de santé, symptômes déclarés) et l'**examen physique** (signes observés ou mesurés). Il sert à apprécier l'état de santé et à orienter les surveillances et les soins.

Entretien clinique	Examen physique
Recueille les **données subjectives** : vécu, plainte, douleur décrite, histoire de santé, traitements, antécédents, contexte et ressources.	Recueille les **données objectives** : signes constatés, examens adaptés, mesures (température, fréquence respiratoire, etc.).

Quatre techniques d'examen physique

Technique	Définition simple	Exemple
INSPECTION	Observer avec soin, principalement par la vue (et autres sens utiles).	Observer le rythme respiratoire et l'aspect de la peau.
PALPATION	Explorer par le toucher, avec méthode.	Apprécier la chaleur cutanée, une sensibilité.
AUSCULTATION	Écouter les bruits internes, habituellement au stéthoscope.	Écoute pulmonaire si enseignée, justifiée et maîtrisée.
PERCUSSION	Tapoter une région corporelle pour apprécier les sons.	Technique à apprendre en enseignement pratique.

POINT IMPORTANT

Ce sont **quatre techniques**, pas un ordre valable pour toute situation. Leur réalisation dépend de la compétence, du contexte, du consentement et des règles d'exercice. Les mesures et examens complémentaires ne sont pas tous autonomes.

Exemple : la plainte « J'ai du mal à respirer »

Subjectif : « Je suis essoufflé depuis ce matin. » **Objectif :** fréquence respiratoire comptée, saturation mesurée, tirage observé, parole difficile. **Analyse :** regrouper les données, comparer à l'état habituel et **alerter rapidement** si détresse ou aggravation.

V. Limites de l'observation et biais

Origine de la limite	Exemples	Attitude utile
Observateur	Fatigue, sens diminués, manque de connaissances, transmission imprécise.	Prendre du recul, vérifier, travailler en équipe.
Personne observée	Réserve, gêne, douleur, réaction modifiée par la présence du soignant.	Demander le ressenti, ne pas forcer, réévaluer.
Contexte	Bruit, lumière, manque d'intimité, urgence ou interruption.	Adapter le lieu, le moment et la méthode.

Trois biais cognitifs à connaître

Biais	Définition	Exemple clinique
CONFIRMATION	Retenir surtout ce qui confirme une idée déjà formée.	« Il exagère » : négliger une nouvelle plainte.
NÉGATIVITÉ	Donner un poids excessif à un élément défavorable.	Ne voir que l'opposition, oublier les capacités.
ANCRAGE	Rester fixé sur la première information.	Garder une première étiquette malgré les signes nouveaux.

COMMENT LIMITER LES BIAIS ?
1. Reconnaître ses automatismes. 2. Distinguer **faits / hypothèses**. 3. Rechercher ce qui pourrait contredire l'hypothèse. 4. Croiser entretien, observation, examen et dossier. 5. Partager le doute en équipe.

Transmettre des données utiles

À éviter : interprétation	À privilégier : donnée factuelle
« Mme A. ne coopère pas. »	« Mme A. refuse la toilette à 8 h ; dit souhaiter attendre après le petit-déjeuner. »
« Le patient va bien. »	« Patient réveillé, échange normalement, dit ne pas avoir mal au repos à 10 h. »
« Il est très angoissé. »	« Il dit : "J'ai peur", respire rapidement et demande la présence d'un soignant. »

OUTIL HAS : SAED
Pour une alerte orale structurée : **S**ituation, **A**ntécédents, **É**valuation, **D**emande. Exemple : « Mme A., dyspnée nouvelle ; antécédent respiratoire ; FR mesurée et signes constatés ; pouvez-vous venir évaluer ? »

Synthèse • rôle IDE • entraînement

La démarche à retenir

RECUEILLIR faits + paroles – **COMPARER** habitudes + dossier – **ANALYSER** hypothèses prudentes – **AGIR / ÉVALUER** surveiller et tracer

EN STAGE : CE QUE FAIT L'ESI AVEC L'IDE

Se présenter et obtenir l'accord ; observer avant, pendant et après le soin ; écouter les plaintes ; relever les données avec les outils appris et sous encadrement ; signaler sans délai un changement préoccupant ; tracer/transmettre selon les procédures du lieu.

Situation clinique guidée

À 9 h, pendant la toilette de M. D. (76 ans) : il dit « Je suis plus fatigué qu'hier ». Vous constatez une toux répétée et une respiration plus rapide qu'à l'accueil ; sa sonnette est au sol.

Étape	Exemple de raisonnement et d'action
Recueil	Subjectif : fatigue déclarée. Objectif : toux, respiration observée, sonnette inaccessible.
Vérification	Demander depuis quand ; comparer aux données antérieures ; mesurer les paramètres pertinents avec l'IDE.
Priorité IDE	Évaluer l'état respiratoire ; identifier une éventuelle détresse ; sécuriser l'environnement ; alerter selon l'urgence.
Transmission	Décrire l'heure, les symptômes, les mesures, les actions réalisées et la réponse de la personne.

Mini-quiz (réponses juste dessous)

1. « J'ai mal au ventre » : objective ou subjective ? **2.** Quel biais pousse à rester sur la première donnée ? **3.** Citer les quatre techniques d'examen physique. **4.** Pourquoi croiser plusieurs sources ?

CORRIGÉ

1. Subjective (parole du patient). **2.** Ancrage. **3.** Inspection, palpation, auscultation, percussion. **4.** Pour contextualiser, vérifier, éviter les interprétations hâtives et adapter les soins.

Lexique express

Donnée subjective : exprimée/ressentie par la personne. **Donnée objective :** constatée ou mesurée. **Signe :** manifestation observée/mesurée. **Symptôme :** manifestation ressentie/rapportée. **Biais cognitif :** raccourci de pensée susceptible de déformer l'analyse.

Sources vérifiées (15/10/2026) : cours IFSI « CM1 – Recueil et perception clinique » (28 p.) ; Arrêté du 20/02/2026, annexe III, UE A.1 ; CSP art. R.4311-3 version en vigueur depuis le 30/06/2026 ; HAS, outil SAED (2014).
Référentiel 2026 • CSP R.4311-3 • HAS SAED

Recueil et perception clinique

Schéma de synthèse détaillé • construit à partir du cours associé

Recueillir

Observer, écouter, mesurer et examiner selon le cadre.

Décrire

Noter des faits précis; distinguer parole rapportée et constat.

Contextualiser

Comparer aux habitudes, au moment et aux autres données.

Interpréter

Formuler une hypothèse, puis rechercher ce qui la confirme ou l'infirme.

Légende et repères d'application

1. Fait : « FR 27/min » ou « dit avoir mal ».
2. Interprétation : une explication à vérifier, pas une donnée brute.
3. Croiser les sources; repérer biais, limites et évolution.
4. Respecter dignité, intimité, confidentialité et parole de la personne.

À retenir

Décrire d'abord. Interpréter ensuite, avec les autres données.

Synthèse visuelle originale, fidèle aux notions du cours source. Utiliser les prescriptions et protocoles applicables.